Diskussion 2162

Datum: 1938-05-27
Kammare: Andra kammaren
Antal yttranden: 2
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.14

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Gustav Möller (Socialdemokraterna, man)

Herr” Pekation, talman! Med andra kammarens tillstånd har herr Bagge, i anslutning till en redogörelse för vissa förhållanden, avseende de i privat sjukvård sysselsatta **sköterskornas³** anställningsoch pensionsförhållanden interpellerat mig, huruvida jag är beredd att vidtaga åtgärder, som syfta till en lösning av hithörande frågor.

Innan jag går att besvara den framställda frågan, vill jag i korthet redogöra för det ärende, till vilket interpellanten anknyter.

I medio av januari 1937 ingav borgarrådet Wictor Karlsson jämte andra den av interpellanten omnämnda framställningen, vari hemställdes, att Kungl. Maj:t ville vidtaga åtgärder för att bereda de i privatvård arbetande **sjuksköterskorna³** tryggare anställningsförhållanden samt pensionsrätt. Framställningen lämnar en ingående redogörelse för de förhållanden, under vilka de i privatvård sysselsatta **sköterskorna³** arbeta. Särskilt betonas de svårigheter, som möta äldre **sköterskor³** vid deras inträde i pensionsåldern.

Av de undersökningar, som av petitionärerna omnämnas, framgår, att år 1936 antalet **sjuksk öterskor³** över 30 år, som ej voro anställda i befattningar, berättigande till pension i statens pensionsanstalt eller kommunala pensionskassor, uppgick till 532. Av dessa voro 178 över 40 år och 90 mellan 35 och 40 år. Sagda omkring 500 **sjuksköterskor³** äro med hänsyn till gällande villkor av 25 tjänstår för full pension vid anställning å reglerad befattning för närvarande definitivt uteslutna från möjligheten att erhålla full pension efter eventuell övergång i allmän tjänst.

Frågan om att uppnå förbättrade utsikter för dessa i privatvård anställda **sjuksköterskor³** erkännes av petitionärerna vara förbunden med betydande svå-

Därutöver antyda petitionärerna, att frågan möjligen skulle kunna lösas på så sätt, att de i privatvård arbetande **sjuksköterskorna³** bleve anslutna till de offentliga sjukvårdsmyndigheterna. Därvid skulle **sköterskorna³** anställas som befattningshavare hos vederbörande myndighet samt åtnjuta avlöningsoch pensionsförmåner, som stode i lämpligt

förhållande till de förmåner, som tillkomma andra fast anställda **sköterskor³**. Alternativt skulle privatvården kunna företrädesvis besörjas, av de yngre **sköterskorna³** och i samband därmed åldersgränsen för anställning å reglerad befattning höjas från den för närvarande praktiskt taget gällande — 30 år — till exempelvis 35 år. En dylik anordning skulle förutsätta, att **sjuksköterska³** finge vid tillträdande av reglerad befattning efter vissa grunder räkna sig till godo jämväl den tid, **hon²** tjänstgjort i oreglerad sjukvårdsverksamhet.

Nu angivna vägar hava emellertid icke synts framkomliga, när det gäller de nuvarande äldre privatsköterskorna. Med tanke på dessa skulle särskilda åtgärder vidtagas. Såsom en övergångsanordning ifrågasattes, att statsbidrag skulle kunna lämnas åt svenska **sjuksköterskornas³** allmänna pensionsförening, till vilken en betydande del, kanske flertalet, av dessa **sköterskor³** redan vore anslutna. Beträffande sådana **sköterskor³**, som redan uppnått 47 års ålder och som därför icke kunde vinna inträde i pensionsföreningen syntes det bliva nödvändigt att ordna ålderdomsförsörjningen i form av rena understöd.

Den ingivna framställningen blev omedelbart föremål för remiss till medicinalstyrelsen, statens pensionsanstalt samt landstingsoch stadsförbunden. Sedermera har den 14 augusti 1937 utlåtande avgivits Jämväl av statskontoret.

Medicinalstyrelsen erinrar, att med hänsyn till den ökade efterfrågan på **sköterskor³** vid sjukhusen, privatsköterskekåren kunde antagas komma att i motsvarande grad minskas. Styrelsen framhåller emellertid tillika, att även vid ett utbyggande av samhällets öppna sjukvård genom anställande av flera distriktssköterskor och stadssköterskor det syntes ofrånkomligt, att privatvården fortfarande bibehölles. Enligt styrelsens mening skulle den föreliggande frågan erhålla en lämplig lösning, därest anslutning till statens pensionsanstalt kunde vinnas exempelvis sålunda, att de godkända sjuksköterskebyråerna utgjorde huvudmän. Därvid vore det tillika önskvärt, att det toges under övervägande, huruvida för ändamålet statsbidrag kunde utgå till byråerna.

Statens pensionsanstalt framhåller beträffande den uppläggning av problemet, som skett i framställningen, att enligt dess åsikt de rena sjukvårdssynpunkterna — och ej önskemålet om beredande av bättre pensionsvillkor åt **sköterskorna³** — borde vara avgörande vid ett eventuellt inordnande av privatvården i den offentliga sjukvården. Om, såsom av framställningen syntes framgå, pensionsfrågan vore kärnpunkten i det föreliggande ärendet, borde därför först och främst undersökas, om icke en tillfredsställande pensionering kunde ordnas utan vidlyftiga rubbningar i den nuvarande organisationen av privatvården. Därvid borde prövas möjligheten av en sådan anordning, att sjuksköterskebyråerna av anslutna **sköterskor³** över exempelvis 30 års ålder obligatoriskt upptoge viss avgift i och för inbetalning till lämplig försäkrings-

Styrelsen för svenska landstingsförbundet erinrar till en början om den otillräckliga tillgången på **sjuksköterskor³** inom den offentliga sjukvården, varigenom av allt att döma allt flera **skö**

terskor³, särskilt de yngre, komme att dragas från privatvården med dess mera osäkra anställningsoch inkomstförhållanden till de reglerade befattningarna i offentlig tjänst. Det vore sålunda att vänta, att antalet privatsköterskor under de närmaste åren komme att avsevärt minskas. Styrelsen framhåller tillika, att det vore helt naturligt, att behovet av **sjuks köterskor³** i s. k. privatvård bleve allt mindre, i samma mån som samhället ginge in för att i stigande omfattning ombesörja även den öppna vården. När distriktsvården bleve utbyggd å landsbygden och införd i alla städer, komme den öppna sjukvården att till väsentlig del omhänderhavas av **sjuksköterskor³** i allmän tjänst. Huru stort arbetsområde, som då kunde komma att återstå för de s. k. privatsköterskorna, vore vanskligt att förutsäga. Behov av ett mindre antal dylika **sjuksköterskor³** syntes dock alltjämt kvarstå. Att för deras räkning ifrågasätta några mera omfattande samhälleliga hjälpåtgärder ansåges åtminstone på nuvarande stadium ej erforderligt.

Det ville sålunda synas, som om spörsmålet om privatsköterskornas anställningsoch pensionsförhållanden skulle vara av större aktualitet allenast under en övergångsperiod, tills den av det allmänna beslutade eller planerade öppna vårdorganisationen bleve fullt genomförd. Under sådana förhållanden syntes man enligt styrelsens mening böra vara synnerligen försiktig, innan man fastlåste privatsköterskeorganisationen i några bestämda former. Framförallt borde en dubbelorganisation undvikas. Starka betänkligheter i detta hänseende ingåve det i framställningen skisserade förslaget, att landstingen m. fl., samtidigt som de vore sysselsatta med distriktsvårdens utbyggande, skulle bliva huvudmän för privatsköterskorna. Med hänsyn till att distriktsvården 1 huvudsak vore avsedd att tillgodose bl. a. just det sjukvårdsbehov, som privatsköterskorna skulle fylla, kunde en dylik organisation icke anses rationell. Man syntes i stället böra inrikta sig på att bereda de privatpraktiserande **sköterskor³**, som ej komme att absorberas i den av det allmänna bekostade sjukvården, lämpliga pensionsförmåner. På vilket sätt detta borde ske vore vanskligt att på frågans nuvarande stadium avgöra. Det förefölle emellertid, som om ett lämpligt avvägt statsunderstöd till **sjuksköterskornas³** pensionsinrättning skulle erbjuda en framkomlig väg.

Styrelsen ställde sig sålunda avvisande till tanken, att huvudmannaskapet för privatsköterskorna skulle påläggas landstingen, men förordade en utredning rörande frågan om de privata **sjuksköterskornas³** uppgifter i sjukvårdsorganisationen, samt deras anställningsoch pensionsförhållanden. Denna

Svenska stadsförbundets styrelse skänker sin anslutning till framställningens allmänna syfte men understryker önskvärdheten av en grundlig inventering av sjuksköterskebehovet. Våra sjukvårdsanstalter utökades, arbetstidens reglering krävde nya tjänster. När det nu ifrågasatts, att det allmänna skulle ikläda sig utgifter för nya grupper av **sköterskor³**, måste en ingående kännedom om rekryteringsbehovet te sig särdeles påkallad. När i framställningen förordades en lösning av problemet, som i görligaste mån tillgodosåge även de äldre **sjukskö terskornas³** önskemål i fråga om pensionsrätt, vore det givetvis mycket behjärtansvärt, att alla möjligheter undersöktes att på denna punkt komma till den bästa möjliga lösning. Tanken

att bland annat städerna såsom huvudmän för sina sjukhus skulle medverka genom inrättande av reglerade tjänster syntes dock vara en mera tveksam utväg. Vid lösningen av försummade pensionsfrågor nödgades man i stadskommunerna ej sällan hänvisa de äldre till en relativt oförmånlig ställning. Att städerna samtidigt skulle ikläda sig utgifter för äldre **sköterskor³** i privatvård syntes under sådana förhållanden föga tilltalande.

Statskontoret gör gällande — i anslutning till vad av styrelserna för svenska landstingsförbundet och svenska stadsförbundet anförts — att med hänsyn till den nuvarande utvecklingen på den slutna kroppssjukvårdens område och till distriktsvårdens och dispensärvårdens utbyggande, det ej kunde bedömas, huru stort arbetsområde, som kunde komma att återstå för s. k. privatsköterskor. Ännu mindre kunde det för närvarande bedömas, om och i så fall under vilka former det allmänna borde lämna sin medverkan till förbättrande av privatsköterskornas anställningsoch pensionsförhållanden.

Vad angår själva huvudsyftet med den föreliggande framställningen, ville statskontoret helt ge sin anslutning till de synpunkter, som statens pensionsanstalt framfört. Således borde enligt statskontorets mening de rena sjukvårdssynpunkterna och ej önskemålet att bereda bättre pensionsvillkor för **sjuksköterskorna³** vara avgörande vid ett eventuellt inordnande av privatsjukvården i den offentliga sjukvården. Utan att på något sätt taga ståndpunkt till frågan om och i vad mån det allmänna borde lämna sin medverkan till ordnandet av privatsköterskornas anställningsoch pensionsförhållanden, anser även statskontoret, att en utredning av hithörande förhållanden borde komma till stånd. Innan några närmare uppgifter förelåge angående den omfattning, i vilken **sjuksköterskorna³** ägna sig åt privatvård, syntes det dock knappast vara möjligt att angiva några riktlinjer för en dylik utredning. I anslutning till vad styrelserna för landstingsförbundet och stadsförbundet anfört, håller statskontoret för önskvärt att som ett första led i en sådan utredning få till stånd en grundlig inventering av sjuksköterskebehovet vid såväl den offentliga som privatvården, varvid särskilt borde beaktas det framtida behovet av privatsköterskor och den omfattning, i vilken sådana **sköterskor³** mera regelmässigt kunde påräkna möjlighet att övergå till allmän sjukvårdsanstalt och där erhålla befattning, som vore förenad med pensionsrätt i statens pensionsanstalt. Enligt vad som anförts i framställningen försigginge inom medicinalstyrelsen en utredning rörande behovet av **sjuksköterskor³**, och ifrågasätter statskontoret, huruvida icke denna utredning lämpligen kunde utvidgas till en sådan mera omfattande inventering, som ämbetsverket antytt.

Såsom den lämnade redogörelsen giver vid handen, är den föreliggande frågan ingalunda lättlöst. I själva verket innesluter densamma två delproblem, nämligen, å ena sidan, det vidare spörsmålet om privatvårdens allmänna orga-

I den ingivna framställningen hava, såsom jag redan framhållit, dessa bägge delproblem sammanförts. Av remissbehandlingen har det enligt min mening framgått, att delproblemen ifråga böra hållas isär. Landstingsförbundet och i sak även stadsförbundet har nämligen från

delvis samma utgångspunkter ställt sig avvisande till tanken att för närvarande i den ena eller andra formen anknyta den nuvarande privatsjukvården till den samhälleliga sjukvården. Då man, såvitt jag kan finna, icke lär kunna tvångsvis ålägga den samhälleliga sjukvårdens huvudmän att i ifrågavarande avseende vidtaga särskilda dispositioner, torde man på denna väg knappast nu hava utsikter att uppnå en bättre ordning. |

Vad åter angår de äldre privatsköterskornas hjälpbehov, kunna billighetsskäl anföras för ett inskridande från statens sida. Om så kan — och under vilka former detta i så fall lämpligen bör — ske, måste bliva beroende av en särskild omprövning. En sådan har ock av mig ansetts böra komma till stånd, något som jag meddelat petitionärerna redan vid framställningens avlämnande. Att jag icke redan funnit mig böra påkalla åtgärder i sådant syfte betingas av flera omständigheter, som jag skall tillåta mig i korthet antyda.

Vid remissbehandlingen har, såsom jag redan erinrat, upplysts, att den undersökning av sjuksköterskebehovet, vilken av petitionärerna betecknats såsom den primära frågan i problemkomplexet, påginge i medicinalstyrelsen. Under dessa omständigheter borde givetvis resultatet av densamma avvaktas, i syfte att erforderliga hållpunkter måtte föreligga för ett mera säkert bedömande av läget i övrigt. Resultatet av sagda utredning har av medicinalstyrelsen redovisats först den 15 oktober 1937. Därvid framgick, att den 31 december 1936 antalet pensionsberättigade sjuksköterskетjänster i riket utgjorde 5,404. Samtidigt funnos för privatvård och vikariat tillgängliga 1,137 **sköterskor**[3]; den 1 oktober 1937 hade sistnämnda siffra reducerats till 870, av vilka 164 uppnått en ålder av 40 år eller däröver. Enligt vad jag inhämtat har den tendens, som sålunda framträtt, till minskning av antalet äldre **sjuksköterskor**[3] jämväl sedermera ytterligare accentuerats, i det att den 20 maj i år, trots ett något ökat totalantal, 915, 159 voro 40 år gamla. Av beskaffenhet att böra beaktas är vidare den omständigheten, att Kungl. Maj:t föreslagit årets riksdag att utvidga distriktssjukvårdsorganisationen jämväl till landstingsstäder med över 5,000 invånare. Riksdagens ställningstagande i denna del var givetvis önskvärt, innan utredningsåtgärder vidtoges. Sedan beslut numera föreligger i detta hänseende, har nödig klarhet skapats även på denna punkt. Slutligen vill jag erinra, att jag avsett att, i samband med förslag till inrättande av en statens sjuksköterskeskola, frågan om sjuksköterskebehovet och dess tillgodoseende skulle bringas under prövning av innevarande års riksdag. Vissa brister i den föreliggande utredningen ha emellertid nödgat till uppskov med åtgärder i sådaut syfte till 1939 års riksdag.

Jag vill alltså sammanfatta min ståndpunkt till interpellantens fråga sålunda, att jag har för avsikt att under den närmaste tiden gå i författning om att en omprövning verkställes av den mera begränsade frågan, om och under vilka former det allmänna må kunna medverka vid pensioneringen av de äldre, i privatvård arbetande **sjuksköterskorna**[3]. Däremot finner jag det mera ovisst, om man redan nu har anledning att närmare överväga på längre sikt inriktade anordningar, mot vilka från huvudmannahåll vägande erinringar framkommit. Att märka är härvid att inom landet i dess helhet föreligger

2. Gösta Bagge (Högerns riksdagsgrupp, man)

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för det svar han varit vänlig ge mig, och jag skall be att därjämte få betyga min uppskattning av att han gjort åtminstone en avvikelse från den traditionella utvecklingen av interpellationsinstitutet — som vi talade häromdagen om i kammaren — då han inte låtit mig vänta i det oändliga utan lämnat svaret ganska snabbt. Därutöver får man nog säga, att interpellationssvaret var synnerligen traditionellt, men jag har ingen särskild anledning klaga på det.

Herr statsrådet framhöll, att man bör skilja mellan två olika delproblem, nämligen å ena sidan det vidare spörsmålet om privatvårdens allmänna organisatoriska ställning till den offentliga sjukvården, och å andra sidan den mera begränsade frågan om eventuella åtgärder från statens sida för att låta äldre privatsköterskor omedelbart komma i åtnjutande av förbättrade pensionsförmåner. Herr statsrådet ansåg att dessa båda frågor böra hållas isär, och den uppfattningen delar jag helt. Herr statsrådet yttrade vidare, att billighetsskäl kunna anföras för att man från statens sida inskrider i vad angår de äldre privatsköterskornas hjälpbehov. När herr statsrådet sedan motiverade, varför han inte nu ämnade vidtaga några åtgärder just i detta hänseende, gick han återigen in på den mera vidlyftiga delen av problemet. Om nu herr statsrådet anser att dessa frågor böra hållas isär, tycker man att frågan om de äldre privatsköterskornas ställning hade bort kunna ordnas rätt snart, oberoende av hur det andra, mycket mer svårlösta problemet ligger till.

Jag är emellertid mycket tillfredsställd med att herr statsrådet förklarade sig under den närmaste tiden planera en omprövning beträffande understöden åt dessa äldre privatsköterskor. Deras ställning är verkligen sådan, att det är mycket angeläget att handla snabbt. Ur rent mänsklig synpunkt är det viktigt att man härvid verkligen skrider till handling så fort som möjligt. Det gäller ju här personer som ägnat ett helt liv åt en strävsam, uppoffrande verksamhet för att hjälpa sina medmänniskor. De leva i mycket blygsamma förhållanden och på ett mycket sparsamt och enkelt sätt, men när de äro gamla finna de, att de inte ha någon möjlighet att klara sig. Jag har en viss personlig anledning att veta hur de ha det, jag känner dem och vet att de leva ett mycket svårt liv och ha det besvärligt på ett sätt som jag verkligen finner vara upprörande, i synnerhet när det gäller människor av den kalibern. Jag är där- Sd som sagt glad över att finna, att vi här skola kunna få någon rätsida på saken.

Beträffande privatsköterskornas ställning överhuvud taget var statsrådet kanske inte lika positivt inställd, tycktes det mig. Han hänvisade till motståndet mot tanken på att anknyta privatvården till den samhälleliga sjukvården och sade, att då man inte tvångsvis lär kunna ålägga den samhälleliga sjukvårdens huvudmän att i detta hänseende vidtaga särskilda dispositioner, kan man knappast på den vägen ha några utsikter att uppnå en bättre ordning. Herr statsrådet fann det även ovisst, om man redan nu hade anledning att överväga på längre sikt inriktade anordningar i detta avseende. — En sådan försiktighet tycker jag nog är en liten smula olik herr Möller — han brukar ta, hur skall jag säga, kraftigare tag även i fråga om

ärenden, som äro betydligt mera invecklade och svårlösta än fallet är med detta. Jag kan

Flera av de myndigheter som yttrat sig i frågan ha föreslagit en utredning. Styrelsen för svenska landstingsförbundet, som motsätter sig privatvårdens anknytning till det allmänna, förordar i alla fall en utredning rörande de privata **sjuksköterskornas³** uppgifter i sjukvårdsorganisationen och deras anställningsoch pensionsförhållanden. Styrelsen ifrågasätter också statsbidrag till **sjuksköterskornas³** pensionsinrättning, vilket jag nyss berörde. Här förefaller det mig som om herr statsrådet hade fått en ganska tydlig vink om att han inte Sure resignera, därför att det visat sig att det finns en hel del praktiska svårigheter.

Jag skulle också vilja stryka under lämpligheten av att man så snart som möjligt ordnar med en sådan utredning som föreslagits. Det förefaller mig som om denna först och främst borde syssla med frågan om behovet av en sådan sjukvård, som hittills ombesörjts av privatvården. För min del anser jag att det tydligt framgår, att sådan sjukvård behöves också 1 framtiden, både som en beredskapstjänst och som en självständig vårdform. Den är nyttig och nödvändig därför att den gör det möjligt att såsom petitionärerna framhållit, avlasta från sjukhusen fall, som faktiskt icke behöva vårdas där. Man har under den senaste tiden hört mycket klagomål från läkarna över att sjukhusvården missbrukas genom att sådana patienter, som lika väl eller bättre kunde vårdas i hemmen, i allt för stor utsträckning ta upp platser på anstalter och sjukhus. Allt detta visar väl, att om vi hade en mera omfattande privatvård, skulle vi inte ha behövt räkna med en sådan platsbrist som nu råder på vissa sjukhus.

Jag hyser således för min del den uppfattningen, att vi inte kunna undvara den privata sjukvården; den blir alltid nödvändig att ha. Jag har också den meningen, att det är galet att låta det nuvarande systemet fortgå så länge, att det uppstår en stor minskning av privatsköterskekåren. Det ligger verklig fara i ett sådant dröjsmål, ty det är mycket svårare att sedan kunna ta upp saken igen. Jag tycker alltså att det finns mycket starka skäl för åtminstone en utredning, inte bara beträffande de äldre **sjuksköterskorna³** utan även i fråga om dessa allmänna problem, en utredning, som bör igångsättas så fort som möjligt. Jag kan inte finna att den skulle behöva bli särskilt vidlyftig eller långvarig, utan med litet god vilja tror jag saken borde kunna ordnas ganska snart.